

УДК: 616-04-006.6-08

*Л.В.Демидов, Н.Т. Балтабеков, С. Сомасундарап, А.А.Ивакин, Е.Е.Симонова, **Г.А.Серикбаев,
**Д.А.Тулеуова, **К.К.Смагулова, **Р.З.Абдрахманов, **А.К.Туманова, **А.К.Курманалиев,
Н.Ю.Насрытдинова, Ш.Т.Пазиров, Ж.М.Акимжанова

*Онкологический Научный Центр РАМН,
Евразийская Ассоциация Онкологов (ЕАФО)

**Казахский НИИ онкологии и радиологии

Казахский НМУ им. С.Д.Асфендиярова, кафедра «Интернатура и резидентура в онкологии»

Адьювантная терапия меланомы кожи с использованием интерферона альфа и надерина. Протокол клинического исследования ЕАФО-2011

Аннотация. Работа посвящена послеоперационной адьювантной терапии меланомы кожи. В 2012 году в Казахстане под контролем Каз НИИОР и ЕАФО начато многоцентровое контролируемое, клиническое исследование по определению эффективности использования интерферона альфа и надерина при меланоме кожи промежуточного и высокого риска прогрессирования.

Ключевые слова: меланома, интерферон альфа, надерин.

Актуальность

Меланома кожи является чрезвычайно злокачественной опухолью. Данное заболевание является самой частой причиной смерти из всех болезней кожи и является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди людей молодого возраста. Смерть от меланомы наступает в более раннем возрасте, чем от других новообразований. По данным Европейской Ассоциации медицинских онкологов на сегодняшний день нет стандартной схемы адьювантного лечения меланомы кожи. С профилактической целью в мире применяются различные виды адьювантной терапии, включая химиотерапию, иммунотерапию: левомизолон, вакцина БЦЖ, интерфероны, нуклеиновые кислоты.

Наибольшее количество рандомизированных исследований в мире было посвящено использованию иммунотерапии рекомбинантными интерферонами. Так по данным Кузнецова В.П. (2002) у меланомы кожи отмечаются четкие признаки влияния иммунной системы на развитие опухоли; полная или частичная самостоятельная регрессия опухоли, метастатические очаги без выявления первичной опухоли, лимфоидная инфильтрация опухолевой ткани, прогрессирование процесса на фоне снижения иммунитета (Кузнецов В.П. 2002). Так с начала 80-ых годов ушедшего столетия было проведено большое количество проспективных кооперированных протоколов, выполненных ведущими исследовательскими группами США и Европы с целью изучения эффективности различных режимов двух

основных препаратов р ИФ а-2а и а-2В у больных меланомой кожи II и III стадий (Демидов Л.В. 2004.).

Полученные данные рандомизированных исследований достаточно противоречивы и не позволяют окончательно оценить роль и место адьювантной иммунотерапии р ИФ-а в профилактике рецидива и прогрессирования заболевания у больных с меланомой кожи II и III стадии. Все это привело к тому что несмотря на определенные успехи, профилактическая иммунотерапия интерфероном альфа до сих пор не является официально утвержденным видом адьювантной терапии меланомой кожи промежуточного и высокого риска в странах Европы и СНГ.

При этом высокодозный режим иммунотерапии интерфероном альфа по 18мл МЕ на м² (30-36 мл МЕ) ежедневно в течении года, используемый в США не нашел широкого применения в Европе и странах СНГ, из-за токсичности и высокой стоимости лечения. В то же время используемые в Европе низкодозные режимы NFα оказались не эффективными при высоком риске прогрессирования заболевания.

В Москве на конгрессе ЕАФО по меланоме кожи в 2011 году было предложено провести в Казахстане пилотное многоцентровое контролируемое клиническое исследование по изучению эффективности адьювантной иммунотерапии интерфероном альфа и надерина с участием экспертной группы ЕАФО.

Экспертная группа исследования

Егермонт А. – Генеральный Директор Онкологического центра имени Густава Русси. Ведущий специалист EORTC в лечении меланом и сарком.г. Париж, Франция.

С. Агарвала (США) – директор программы по иммунологии в онкологическом центре св Луи. Руководитель исследования E 1697 меланомного комитета Восточной Кооперированной онкологической группы ECOG
Демидов Л.В. (Россия) – руководитель отделения биотерапии НИИ клинической онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина г. Москва. Председатель Российского Экспертного Совета по меланоме.

Сомасундарап С. (Индия) – директор ЕАФО (Ассоциация Онкологов Европы и Азии)

Цель исследования

Улучшение результатов хирургического лечения меланомы кожи.

Задачи исследования

Оценить эффективность среднедозной иммунотерапии интерфероном альфа в сочетании с надерином при меланоме кожи промежуточного и высокого риска в адъювантном режиме.

Определить результаты самостоятельной среднедозной иммунотерапии интерфероном альфа при меланоме кожи промежуточного и высокого риска в адъювантном режиме.

Изучить при меланоме кожи промежуточного риска эффективность самостоятельного применения надерина в адъювантном режиме.

Дать оценку динамике показателей клеточного иммунитета и уровня онкомаркера S-100 в процессе лечения меланомы кожи высокого и промежуточного риска прогрессирования.

На основании полученных результатов заявить наиболее эффективную схему адъювантного лечения при меланоме высокого и промежуточного риска метастазирования.

Материалы и методы исследования

Материалом для исследования являются больные меланомой кожи с гистологическим верифицированным диагнозом после хирургического удаления опухоли и ее регионарных метастазов.

Критерии включения

- гистологический верифицированный диагноз
- операбельная форма
- T2-4N0 M 0 – промежуточный риск
- T1-4N 1 M 0 – высокий риск;
- статус по шкале B03<2, активность по шкале Карновского более 70%
- отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний в стадии декомпенсации
- возраст от 18 до 80 лет.

Методы диагностики меланомы

- Опрос (наличие симптомов малигнизации)
- Обычный осмотр (правильно ABCDE)
- Дермотоскопия
- Кровь на S-100, СД4/СД8

Открытая тотальная носовая биопсия под общим обезболиванием, с цитологическим и гистологическим исследованием, с определенном степени инвазии по Кларку и Бреслау

Методы лечения меланомы кожи

Первым этапом лечения для всех групп было хирургическое удаление основного очага и увеличенных регионарных лимфатических узлов под общей анестезией.

Затем в зависимости от стадии опухолевого процесса и вида адъювантного лечения больные были разбиты путем рандомизации на следующие группы.

Меланома высокого риска

Метастазирования T1-4N 1-2 M 0, или T1-4N 0 M 0 местный или регионарный рецидив после хирургического лечения.

Основная группа: интрон А+ надерин индукционный курс NFA 18мл МЕ внутри можно с интервалом 7 дней, в течении одного месяца и надерин по 2др. per oss 1 раз в день, поддерживающая терапия интерферон альфа по 9мл МЕ внутрикожно один раз в месяц в сочетании с

ежедневным приемом надерина по 2 дражке per oss в течении года

Основная группа интрон А(NF) индукционный курс только NF 18мл МЕ внутрикожно, с интервалом 7 дней в течении месяца, затем поддерживающая терапия NF по 9мл МЕ 1 раз в месяц в течении года.

Контрольная группа - полихимиотерапия по схеме дакарбазин 1400мл, цисплатин 50мл внутривенно 6 курсов с интервалом 21 день

II меланома промежуточного риска

Метастазирования T1-4N 0 M 0

Основная группа: интрон А+надерин NF18мл МЕ N4 с интервалом 7 дней, затем 9 мл Ме в/к с интервалом месяц в течении года + надерин по 2 дражке 1 раз в день в течении года

2. Основная группа: интрон А(NF) 18 млМЕ N4, с интервалом 7 дней, затем 9мл МЕ в/к с интервалом месяц в течении года

3. Контрольная группа – надерин по 2 дражке 1 раз в день в течение года.

Критерии оценки эффективности проводимого лечения.

1. Увеличение без рецидивного периода
2. Увеличение общей выживаемости
3. Динамика маркеров опухолевого процесса – S- 100, CD 4/CD 8
4. Качество жизни больных во время лечения
5. Уровень лейкопении, охват лечением

Ожидаемые результаты

1. Высокие дозы интерферона в сочетании с надерином сохраняют антипролиферативные свойства - но за счет надерина легче переносятся, ожидается значительное снижение токсичности, лейкопении, иммунодефицита.

2. Сочетание ИФальфа и надерина позволит увеличить без рецидивный период в среднем на 30%, по сравнению с полихимиотерапией и чисто хирургическим лечением.

3. Снижение финансовых затрат по сравнению с существующими в США и Европе стандартами адъювантного лечения в 7-8 раз.

4. Повышение качества жизни пролеченных больных – возможность получения терапии амбулаторно.

Предварительные результаты

В период с 2012 года по 2013 начато исследование у 63 пациентов с меланомой кожи.

Из 63 больных 9 исключены из протокола из-за нарушения режима и схем лечения и у одного пациента начавшего лечение при пересмотре гистологии и ИТХ диагноз меланома не подтвердился, выявлено Т-клеточная лимфома кожи.

Из запланированных 7 клинических центров в настоящее время проводится в 4, включая КазНИИ О и Р, ООД ЮКО г.Шымкент, онкологический центр медицинской Академии г.Актюбинск, Региональный Областной Онкологический диспансер г.Алматинской области.

Набор клинического материала продолжается до декабря 2014 года.

Выводы

1. Адъювантная терапия меланомы кожи по данным литературы остается не решенной проблемой клинической онкологии.

2. Данные зарубежных рандомизированных исследований США Европы разноречивы, поэтому отсутствует единый стандарт адъювантной терапии

меланомы кожи промежуточного и высокого риска.

3. Наиболее перспективным направлением адъювантной терапии меланомы кожи по данным ЕАФО является комбинация интерферона альфа и надерина, позволяющая снизить токсичность, повысить эффективность и переносимость высоких доз интерферона альфа.

4. Меланома кожи иммунозависимая опухоль и требует контроль за уровнем клеточного иммунитета до, во время и после лечения, для определения эффективности терапии и своевременного выявления прогрессирования заболевания, особенно в сочетании с определением уровня онкомаркера S-100.

5. Для определения наиболее оптимальных схем лечения и выработки единого стандарта необходимо проведение в Казахстане собственных многоцентровых, контролируемых, клинических исследований включая Каз НИИ Онкологии и Радиологии и областные онкологические диспансеры.

Список литературы

1. Лемехов В.Т. Эпидемиология, факторы риска, скрининг меланомы кожи // Практическая онкология: избр. лекции / под. ред. С.А. Тюляндина и В.М. Моисеенко. – СПб.: Центр ТОММ, 2004. – С. 513
2. Балтабеков Н.Т. Пути улучшения диагностики и лечения меланомы кожи: дис... д-ра мед. наук: 14.00.14 – Алматы, 2009-С. 93
3. Eygermont A.M. Strategy of the EORTC-MCG trial programme for adjuvant treatment of moderate-risk melanoma // Europ. J. Cancer. – 1998 – Vol. 34. – P. 822-826.
4. Balch Metall C. Cutaneous Melanoma (second edition). – Philadelphia: J. B. Lippincott, 1992-583 p.
5. Анисимов В.В. Меланома кожи (перспективы улучшения диагностики и лечения: дис.... д-ра мед. наук: 14.00.14 – СПб: 2000г., 97 с)
6. Демидов Л.В., Харкевич Г.Ю. Адъювантное лечение больных меланомой кожи // Практическая онкология: избр. лекции / под. ред. А.С. Тюляндина и В.Н. Моисеенко. – СПб: Центр ТОММ, 2004. – С. 573-583.
7. Коровин С.П., Кукушкина М.Н., Толстомятов Б.А. Результаты лечения больных с метастазами меланомы кожи // Материалы V съезда онкологов стран СНГ, - Ташкент, 2008.- с.341
8. Kirkwood J.M. Strawderman M.N., Ernstoff M.S. Interferon alfa – 2 β adjuvant therapy of high-risk resected cutaneous melanoma: The Eastern Cooperative Oncology Group Trial EST 1684 // J. Clin. Oncology. – 1966. – Vol. 14- P. 7-17.
9. Quirt J.C., Shelly W.E., Pater W.L. Biologic properties of recombinant alfa interferons: 40 th anniversary of the discovery of interferons // Cancer Res. – 1998. – Vol. 58 – P. 2489
10. Кузнецов В.П., Кошенкова О.А., Беляев Д.А. Процентное соотношение общих иммуноглобулинов как важный критерий иммунологического статуса // Материалы VIII международного конгресса иммунореабилитации (Канны, Франция; 21-24 апреля 2002 год) – 2002 – С. 77

Тұжырым

Л.В.Демидов, Н.Т.Балтабеков, С.Сомасундурап, А.А.Ивакин, Е.Е.Симонова, Г.А.Серікбаев, Д.А.Тұлеуова, Қ.Қ.Смағұлова, Р.З.Әбдірахманов, А.К.Туманова, А.Қ.Құрманалиев, Н.Ю.Насрытдинова, Ш.Т.Пазілов, Ж.М.Акимжанова

ОНЦ РАМН, ісіктердің биотерапия бөлімшесі.

Онкологтардың Еуразиялық Қоғамы (ЕАФО)

Қазақ онкология ҒЗИ, сүйек, жұмсақ тіндер ісіктері және меланома орталығы.

ҚазҰМУ «Онкологиядағы интернатура және резидентура» кафедрасы.

Жұмыс тері меланомасын операциядан кейінгі адъюванты еміне арналған

2012 жылы Қазақстанда ҚазОПҒЗИ және ЕАФО бақылауымен тері меланомасының аралық және жоғарғы қауіпшілік қалу кезіндегі интерферон альфа және надериннің тиімділігін пайдаланып анықтауының көп орталықты бақылаулық, клиникалық зерттеу басталды.

Түйінді сөздер: тері меланомасы, шырқалу, интерферон альфа, надерин.

Summary

L.V.Demidov, N.T.Baltabekov, S.Somasundarap, A.A.Ivakina, E.E.Simonova, G.A.Serikbaev, D.A.Tuleuova, K.K.Smagulova, R.Z.Abdrahmanov, A.K.Tumanova, A.K.Kurmanaliev, N.Y.Nasrytdinova, Sh.T.Pazilov, Zh.M.Akimzhanova

OSC PAMTS, Department of biotherapy of tumors

Eurasian Association of Oncology (EAFO)

Kazakh Research Institute of Oncology, Center of bone tumors, soft tissue and melanoma.

KazNMU Department «internship and residency in oncology»

The work is devoted to post-operative adjuvant therapy of melanoma.

In 2012 in Kazakhstan under the control KazNIOiR and EAFO initiated, multicenter, controlled clinical trial to determine the effectiveness of the use of interferon-alfa and naderine melanoma skin intermediate and high risk of progression.

Keywords: skin melanoma progression, interferon alpha, naderine.